

Les aspects communicationnels de la rencontre avec le malade et sa famille

Dr Bououden

Module de Psychologie Médicale

Université de Constantine

Plan du cours:

- I-Introduction
- II-Historique
- III- RELATION, COMMUNICATION, INFORMATION
- IV-Objectifs de la communication
- V-Processus de la communication:
- VI-Outil pour une bonne communication
- VII-Techniques de communication de base
- VIII- Communication avec la famille du malade
- IX-Co n c l u s i o n

I-Introduction:

- L'entretien entre le médecin et le patient constitue le fondement d'une bonne prise en charge.
- Les patients veulent être entendus quand il s'agit de diagnostiquer et, le cas échéant, de traiter leurs plaintes.
- La communication est une conduite psychosociale visant à transmettre une information par l'emploi du langage, des gestes, des attitudes ou des mimiques.

- Dans une relation de soin, la communication revêt une place particulière:
 - * D'une part une communication de qualité permet une **efficacité du fonctionnement** : par exemple, lors de l'interrogatoire, **communiquer permet** de recueillir des données utiles au bilan, ce qui s'inscrit dans l'identification du problème et donc dans l'efficacité du soin.
 - * D'autre part, la profession de soin comporte dans son essence **des valeurs d'humanité**. La relation thérapeutique prend tout son sens en permettant de **faire circuler l'écoute, l'empathie, le « prendre soin »**.

II-Historique

- . Au début des années 70, des experts ont, pour la première fois, analysé des entretiens entre médecins et patients et observé que **la communication** était **pauvre** et largement **inadéquate**.
- Les médecins **interrompaient** fréquemment le récit des patients après **moins d'une minute**, passant ainsi quelquefois à côté d'informations importantes sur leur état.
- Certains patients **ne comprenaient** pas les informations communiquées par leur médecin et lorsqu'ils quittaient le cabinet, **ne savaient** ni ce que leur médecin venait de leur expliquer, ni ce qu'ils **devaient faire**.

III- RELATION, COMMUNICATION, INFORMATION

- Ces termes méritent d'être précisés. Ils recouvrent des réalités voisines mais différentes :
- - La relation entre le soignant et son malade : il s'agit du climat de confiance pouvant s'installer entre des individus . Un exemple type de tels phénomènes est le sentiment d'être suffisamment informé.
- - La communication: est un échange de messages entre les personnes. Elle suppose l'existence d'émetteurs et de récepteurs — ce sont les soignants et les soignés — ainsi qu'un système de transport de messages par vecteurs verbaux, écrits ou comportementaux dans un espace d'expansion défini.

- 
- La communication est un des aspects de la relation, élément essentiel car de sa qualité dépend celle de la relation.
 - Quant à l'information, : c'est le contenu du message. Une information est riche quand son contenu nous apprend quelque chose.

IV-Objectifs de la communication

- les objectifs de la communication entre le médecin et le patient :
 - 1. Recueillir des informations;
 - 2. Informer le patient;
 - 3. Tenir compte des sentiments du patient.
 - 4. Développer, entretenir et conclure une relation; afin d'obtenir **une observance thérapeutique**.
 - 5. Identifier la nature du problème et en contrôler l'évolution;
 - 6. Etablir un plan thérapeutique; et **l'éducation thérapeutique**.
- .

V-Processus de la communication:

- Le schéma de la communication se présente comme ceci « Schéma de Shannon¹ » :
 - * **L'émetteur** est la personne qui envoie un message contenant les informations qui doivent être transmises,
 - * La personne qui le reçoit **est le récepteur**.
 - * **Différents canaux** peuvent être utilisés (Verbal, Non verbal, écrit ...).
 - * **Le support** est l'outil utilisé afin de transmettre le message,
 - * **Enfin le feed-back (rétroaction)** est le message « réponse » du récepteur à l'émetteur.
 - * On parle également **de codage**, il est important que l'émetteur et le récepteur utilisent le même code, c'est-à-dire un langage commun afin que le message puisse être décodé par le récepteur. Par exemple lorsqu'un soignant s'adresse à un patient, il devra veiller à ne pas utiliser de jargon médical.

Annexe I : Schéma de Shannon



- Les cinq axiomes concernant la communication:
- 1. On ne peut pas ne pas communiquer.
- 2. Toute communication présente deux aspects: le contenu et la relation.
- 3. La communication est toujours à la fois cause et effet.
- 4. La communication humaine utilise deux modes de communication: digitale et analogique.
- 5. La communication est soit symétrique, soit complémentaire (dans le domaine de la santé, car il met en évidence que la communication n'est pas toujours symétrique (comme c'est le cas quand les rapports de force sont équilibrés), mais qu'elle peut aussi être complémentaire quand des différences importantes séparent les participants).

VI-Outil pour une bonne communication

- Plusieurs outils ont été élaborés en vue d'améliorer la communication. C'est le cas du cadre SEGUE , conçu par l'Université Northwestern de Chicago (Illinois, États-Unis):
 - **Set the stage (préparer l'entretien)**
 - **Elicit information (obtenir des informations)**
 - **Give information (fournir des informations)**
 - **Understand the patient's perspective (comprendre le point de vue du patient)**
 - **End the encounter (mettre un terme à l'entretien).**

VII-Techniques de communication de base

- **EPICES : un outil de communication**
- L'outil de communication EPICES, « Environnement, Perception, Invitation, Connaissances, Empathie, Stratégies et Synthèse », traduction du moyen
- mnémotechnique anglais « SPIKES », peut être employé pour aider pour faciliter la communication avec les patients

- **Étape 1 : écouter (E)**
- *Confidentialité* : L'environnement joue un rôle
- important lorsque des sujets sensibles doivent être
- abordés. Le patient doit pouvoir écouter et poser des
- questions sans être dérangé.
- *Faire participer les êtres chers* : Il faut toujours demander aux patients s'ils souhaitent qu'un membre de leur famille ou un proche soit présent pour les soutenir et les aider à assimiler les informations.

- *S'asseoir*: cela permet une communication directe et montre au patient que le professionnel souhaite prendre son temps.
- Il faut toujours sembler calme et regarder le patient dans les yeux si cela est culturellement approprié.
- Parfois, lorsqu'un patient pleure, il vaut mieux regarder ailleurs et lui permettre de s'isoler pour se reprendre.
- *Écouter*
- L'écoute des patients, sans les interrompre, est une
- tâche importante du professionnel de santé. Garder
- le contact visuel et le silence est une bonne façon de
- manifester son intérêt et sa bienveillance au patient.

- **Étape 2 : percevoir (P)**
- Il s'avère souvent judicieux de demander au patient son avis sur la situation. Cela peut aider le professionnel de santé à comprendre ce que le patient a intégré de sa situation.
- **Étape 3 : inviter (I)**
- Quel volume d'informations on doit fournir au patient ? : se concentrer sur les besoins d'information propres à chaque patient .
- Chaque patient est différent, tout comme le volume d'informations qu'il veut ou peut assimiler. donc se concentrer sur chacun d'eux afin d'identifier ce qu'ils veulent savoir et le volume d'information qu'ils souhaitent obtenir.

- 
- Pour éviter toute surcharge d'information, il faut poser certaines questions, ou dire certaines phrases, simples, au début de la
 - consultation. Par exemple ;
 - *Nous allons maintenant vérifier ensemble que je vous ai*
 - *donné suffisamment d'informations concernant votre*
 - *diagnostic et/ou votre traitement.*
 - *Ou : N'hésitez pas à me dire, à tout moment, si vous pensez avoir suffisamment d'informations pour le moment*

- **Étape 4 : connaître (C)**
- Pour communiquer efficacement avec les patients, il
- faut toujours **les prévenir** que des informations
- difficiles vont leur être communiquées. Les patients
- ont ainsi le temps de se préparer, même s'il ne s'agit
- que de quelques minutes. Par exemple : *M. Ahmed, j'ai*
- *malheureusement de mauvaises nouvelles à vous*
- *apprendre*

- **Étape 5 : explorer (E)**

- Pour être attentifs aux besoins émotionnels des patients:
- •Naming : nommer les émotions: Écoutez et identifiez **les émotions du patient**. Si vous n'êtes pas sûr des émotions qui sont exprimées ou ressenties, posez des questions telles que : *Que ressentez-vous ?*
- Understanding : dans la mesure du possible, exprimer de la compréhension pour ces émotions
- Respecting : exprimer du respect ou de la reconnaissance pour le patient
- Supporting : apporter son soutien au patient
- Exploring : investiguer d'autres aspects propres aux émotions
- Gardez le silence. Parfois, le plus important est d'être présent, de laisser le patient intégrer les informations et de lui donner une chance de poser des questions.

- **Étape 6 : synthétiser**

- A la fin de la consultation, il est toujours judicieux de résumer les informations abordées. Les patients peuvent avoir des questions supplémentaires ou se
- souvenir de quelque chose d'important. Si de
- nouveaux problèmes sont soulevés à la dernière
- minute, il convient de fixer un autre rendez-vous.

VIII- Communication avec la famille du malade

- La rencontre médecin/patient/famille implique un interlocuteur supplémentaire : la famille, dont le mode de fonctionnement est inconnu et variable. Rencontrer une famille pour annoncer l'état de santé de leur proche doit se préparer,
- Le médecin doit maîtriser sa communication verbale et non verbale (analogique), qui exprime à notre insu nos émotions et nos sentiments. Il doit adopter une démarche structurée pour transmettre les informations aux proches :
- Prendre son temps et écouter les proches avant de parler.
- Puis prendre la parole et décrire l'histoire médicale du patient : de la prise en charge initiale, à l'admission dans le service et de ce qui a été mis en place pour le patient, puis énoncer un diagnostic et pronostique.

I - Débuter l'entrevue

A - Préparer l'entrevue

B - Établir le premier contact (l'accueil)

1. **Le médecin salue** le patient et obtient son nom.
2. **Se présente** et précise son rôle, la nature de l'entrevue ; obtient le consentement du patient, si nécessaire.
3. **Montre du respect** et de l'intérêt ; veille au confort physique du patient (du début à la fin de l'entrevue).

C - Identifier la (les) raison(s) de consultation

1. **Identifie**, par une question adéquate d'ouverture, les problèmes ou préoccupations que le patient souhaite voir aborder durant l'entrevue (« *Quels problèmes vous amènent aujourd'hui ?* » ou « *Qu'est-ce que vous souhaiteriez discuter aujourd'hui ?* »)
2. **Écoute** attentivement les énoncés de départ du patient, sans l'interrompre ou diriger (orienter) sa réponse
3. **Confirme la liste initiale des raisons de consultation** et vérifie s'il y a d'autres problèmes (« *Donc, il y a les maux de tête et la fatigue. Y a-t-il autre chose dont vous aimeriez parler aujourd'hui ?* »)
4. **Fixe, avec l'accord du patient, l'agenda** de la rencontre en tenant compte, à la fois, des besoins de ce dernier et des priorités cliniques

Conclusion

- La société réclame des médecins plus humains et communiquant mieux avec les patients.
- Les cliniciens expérimentés et les chercheurs des domaines de l' éducation médicale et de la communication soulignent le rôle central de la communication médecin-patient dans la démarche clinique pour le succès des stratégies de diagnostic et de traitement.

- 
- « On ne doit pas chercher à guérir le corps sans chercher à guérir l'âme. » (Platon)*